

FRONT

PATIENT INFORMATION LEAFLET

Device Type: Intraocular Lens (Phakic)

Introduction
This patient information leaflet is designed to help you decide whether you want to have an Implantable Phakic Contact Lens (IPCLS) placed in one or both eyes to correct your nearsightedness (myopia) or farsightedness (hyperopia). It is important to understand the benefits and possible risks before making a decision. Please read this leaflet carefully and discuss any questions with a doctor who specializes in IPCLS surgery.

What Is Nearsightedness and Farsightedness?

NORMAL EYE
Light focuses on the retina. Vision is clear.

NORMAL EYE:
Your eye works like a camera. You use objects because your eye focuses light into images. Both the clear front layer of your eye, called the cornea, and your natural crystalline lens focus rays of light onto the back surface of the eye, called the retina.

NEARSIGHTED EYE
Light focuses in front of the retina. Vision is blurry.

NEARSIGHTED EYE:
Nearsightedness is a focusing error that causes blurrer vision at distance than at near. Light from an object in the distance focuses in front of the back surface of your eye (retina) responsible for capturing images, rather than directly on the retina.

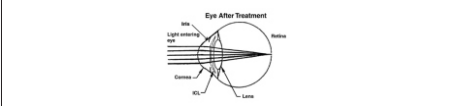
FARSIGHTED EYE
Light focuses behind the retina. Vision is blurry.

FARSIGHTED EYE:
Farsightedness (hyperopia) is a common vision condition in which you can see distant objects clearly, but objects nearby may be blurry.

Glasses and contact lenses can help your eye focus light properly on the retina. The IPCLS can also help your eye focus light properly on the retina.

How Does IPCLS Correct Nearsightedness and Farsightedness?

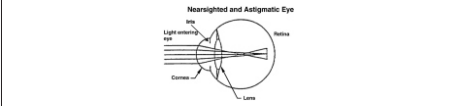
CORRECTION OF VISION AFTER IPCLS SURGERY



A diopter (D) is a unit used to measure how well your eye can focus. It shows the level of nearsightedness, farsightedness, or astigmatism you have. IPCLS surgery can treat nearsightedness from -0.5D to -15.0D and farsightedness from +0.5D to +15.0D. If you have vision fall within these ranges, this surgery may help you see clearly without glasses or contact lenses.

The IPCLS noninvasively tests your vision and helps you understand if you are a good candidate for this surgery. It can correct nearsightedness or farsightedness, but it cannot correct astigmatism or uneven vision. It happens when the front surface of the eye (cornea) is not evenly shaped. Because of this, light does not focus properly inside the eye, and some parts of what you see look clearer than others.

NEARSIGHTED AND ASTIGMATIC EYE



IPCLS Toric / IPCLS Presbytic Toric can correct any astigmatism you have up to +1.0 D to +10.0. You are requested to consult your doctor to choose appropriate suitable options for your eyes.

Choosing the best lens for your vision

There are different types of lenses available. Your eye doctor will help you choose the one that is best for you. Other treatment options include glasses with thick lenses or contact lenses with a permanent lens implant. Talk to your eye doctor about the benefits and possible risks of each option.

Other Treatments to Correct Nearsightedness and Farsightedness?

Other treatments to correct nearsightedness and farsightedness include eyeglasses, contact lenses, and refractive surgical procedures. Surgical options include Photorefractive Keratectomy (PRK), Laser-Assisted In Situ Keratomilexis (LASIK), refractive lens exchange (RLE), and phakic intraocular lens implantation (e.g., IPCLS). However, these procedures may not meet the visual requirements for certain professions, such as military service.

These procedures either reshape the cornea or place a lens inside the eye. PRK and LASIK use a laser to change the shape of the cornea so the eye can focus better. In LASIK, a thin flap of the cornea is lifted, the laser reshapes the tissue underneath, and the flap is put back in place to heal. Phakic intraocular lens implantation, like IPCLS, adds an artificial lens inside the eye without removing your natural lens.

Benefits And Risks of the IPCLS

IPCLS surgery can safely correct nearsightedness between -0.5D to -15D and farsightedness between +0.5D to +15D. If your eyesight prescription is in these ranges, the IPCLS may make your distance vision without eyeglasses or contact lens correction better.

Implanting IPCLS requires eye surgery, which carries potential risks. Please read this leaflet carefully and talk to your doctor about the possible risks.

Few of the risks are as below

- Additional surgery
- Sometimes, a second surgery may be needed to remove, replace, or adjust the IPCLS. It may need to be removed during contact surgery. Additional surgery might also be needed to reduce eye pressure.

Cataract formation
After Phakic IOL surgery, there is an increased risk that the natural lens of your eye may become cloudy, leading to cataracts that could require surgery. The longer the IPCLS stays in the eye, the higher this risk becomes. Regular eye exams are important to check for cataracts. Older patients and those with stronger nearsightedness or farsightedness may have a higher risk. The long-term risk beyond 7 years is not known. If cataract surgery is needed, the IPCLS and the cloudy lens are removed, and a new lens is implanted, which requires additional surgery.

Loss of Best Corrected Vision (BCVA)

The most common reason was clouding of the natural lens (cataract). Vision may get better in these eyes after cataract surgery.

Increased intraocular pressure (IOP) can damage the optic nerve caused by increased pressure in eye (Glaucoma)
Normal eye pressure (intraocular pressure or IOP) can vary but is often considered to be from 10-21 millimeters of mercury (mmHg). An IOP higher than normal is called ocular hypertension and if left untreated, can cause damage to the optic nerve (glaucoma) and cause permanent vision loss.

Endothelial Cell Loss

The cornea (the clear front part of your eye) has a type of skin cells called endothelial cells. These cells keep the cornea clear by removing extra fluid. Normally, the number of these cells slowly decreases with age. Eye surgery, including IPCLS, can cause additional loss of cells. If too many cells are lost, the cornea can become cloudy and affect your vision. Before surgery, your doctor will examine your eyes to check if you are suitable for IPCLS. After the surgery, some ongoing loss of these cells may occur over time. If too many cells are lost, fluid can build up in the cornea (called corneal edema), which may require a cornea transplant.

Other Complications

- Other risks associated with IPCLS surgery may include:
 - movement of the colored portion of the eye (iris) through a surgical wound to a position outside the eye (iris prolapse),
 - bleeding under the retina (subretinal hemorrhage),
 - bleeding under the retina (subretinal hemorrhage),
 - increased or focusing error (astigmatism),
 - flitting or pulling of the retina from its natural position (retinal detachment),
 - unusual pupil size (anisocoria).

Adverse reactions and complications due to, or following surgery and implication of any implantable Phakic Contact Lens may include, but are not limited to:

- Increased inflammation
- Refractive error not equal to the prescription
- Intraocular infection
- Secondary glaucoma
- Uveitis
- Hyphema
- Anterior subcapsular cataract
- Severe intraocular inflammation
- Glaucoma
- Secondary glaucoma
- Uveitis
- Hyphema
- Under/over correction
- Non-reactive pupil
- Endophthalmitis
- TASS
- Retinal Detachment
- Iritis
- Cystoid macular edema
- Nuclear edema
- Corneal decompensation
- Corneal edema
- Papillary block
- Inc Capture
- IOP >5mmHg over baseline and IOP >25 mmHg
- Significant glare and/or halos around lights
- Decentration/rotation of the IPCLS
- Calcification of the retina
- Lens dislocation/rotation of the IPCLS
- Loss of best spectacle corrected visual acuity
- Secondary surgical intervention to remove/replace the IPCLS

NOTICE D'INFORMATION DESTINÉE AU PATIENT

Type de dispositif : Lentille intraoculaire (phake)

Introduction
Ce notice d'information destinée au patient a été conçue pour aider à décider si vous souhaitez ou non une lentille de contact phakique implantable (IPCLS) et si vous souhaitez ou non dans les deux yeux afin de corriger votre myopie ou votre hypermétropie. Il est important de comprendre les avantages et les risques potentiels avant de prendre votre décision. Veuillez lire attentivement cette notice et discuter de toute question avec un médecin spécialiste en chirurgie IPCLS.

Qu'est-ce que la myopie et l'hypermétropie ?

ŒIL NORMAL
La lumière se focalise sur la rétine. La vision est nette.

ŒIL NORMAL :
Votre œil fonctionne comme un appareil photo. Vous voyez les objets parce que votre œil focalise la lumière pour former des images. La couche transparente située à l'avant de votre œil, appelée cornée, ainsi que votre cristallin naturel, focalisent les rayons lumineux sur la surface arrière de l'œil appelée rétine.

ŒIL MYOPE
La myopie est un défaut de focalisation qui provoque une vision plus floue de loin que de près. La lumière provenant d'un objet éloigné se focalise devant la surface arrière de votre œil (la rétine), responsable de la capture des images, au lieu de se focaliser directement sur la rétine.

ŒIL MYOPE :
L'hypermétropie est un trouble visuel fréquent dans lequel vous pouvez voir clairement les objets éloignés, tandis que les objets proches peuvent apparaître flous.

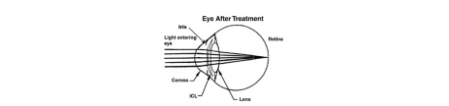
ŒIL HYPERMÉTROPE
La lumière se focalise derrière la rétine. La vision est floue.

ŒIL HYPERMÉTROPE :
L'hypermétropie est un trouble visuel fréquent dans lequel vous pouvez voir clairement les objets éloignés, tandis que les objets proches peuvent apparaître flous.

Les lunettes et les lentilles de contact peuvent aider votre œil à focaliser correctement la lumière sur la rétine. L'IPCLS peut également aider votre œil à focaliser correctement la lumière sur la rétine.

Comment l'IPCLS corrige-t-elle la myopie et l'hypermétropie ?

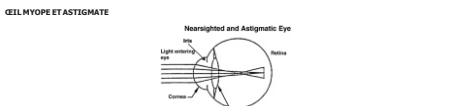
CORRECTION DE LA VISION APRÈS UNE CHIRURGIE IPCLS



La dioptrie (D) est une unité utilisée pour mesurer la capacité de votre œil à effectuer correctement la mise au point. Elle indique le degré de myopie, d'hypermétropie ou d'astigmatisme dont vous êtes atteint. La chirurgie IPCLS peut traiter la myopie de -0,5 D à -15,0 D et l'hypermétropie de +0,5 D à +15,0 D. Si votre vision visuelle se situe dans ces gammes, cette intervention peut vous aider à voir clairement sans lunettes ou lentilles de contact.

La lentille monofocale IPCLS ne corrige pas l'astigmatisme. L'astigmatisme est un trouble visuel fréquent qui provoque une vision floue ou irrégulière. Il survient lorsque la surface antérieure de l'œil (la corne) n'a pas une forme parfaitement régulière. En conséquence, la lumière ne se focalise pas correctement à l'intérieur de l'œil et certaines parties de ce que vous voyez peuvent paraître plus nettes que d'autres.

ŒIL MYOPE ET ASTIGMATISME



L'IPCLS Toric / IPCLS Presbytic Toric peut corriger un astigmatisme de +1,0 D à +10,0. Vous êtes demandé de consulter votre médecin afin de choisir l'option la plus appropriée à votre cas.

Choisir la meilleure lentille pour votre vision

Il existe différents types de lentilles disponibles. Votre ophtalmologiste vous aidera à choisir celle qui vous convient le mieux. D'autres options de traitement comprennent les lunettes à verres souples ou les lentilles de contact au lieu d'une intervention chirurgicale. Discutez avec votre ophtalmologiste des avantages et des risques potentiels de chaque option.

Autres traitements pour corriger la myopie et l'hypermétropie ?

Les autres traitements destinés à corriger la myopie et l'hypermétropie comprennent les lunettes, les lentilles de contact et les procédures chirurgicales réfractives. Les options chirurgicales comprennent la kératoplastie photoréfractive (PRK), le laser assisté in situ kératomilexis (LASIK), l'échange de cristallin réfractif (RLE) et l'implantation de lentilles intraoculaires phakiques (par exemple, l'IPCLS). Toutefois, ces procédures peuvent ne pas répondre aux exigences visuelles de certaines professions, telles que le service militaire.

Ces procédures consistent soit à remodeler la corne ou à placer une lentille à l'intérieur de l'œil. La PRK et le LASIK utilisent un laser pour modifier la forme de la corne afin d'améliorer la capacité de l'œil à effectuer la mise au point. Dans le LASIK, un flap corneen est soulevé, le laser remodelle le tissu sous-jacent, puis le volet est replacé afin de cicatriser. L'implantation d'une lentille intraoculaire phakique, telle que l'IPCLS, ajoute une lentille artificielle à l'intérieur de l'œil sans retirer votre cristallin naturel.

Avantages et risques de l'IPCLS

La chirurgie IPCLS peut corriger une faiblesse visuelle comprise entre -0,5 D et -15 D ainsi que l'hypermétropie comprise entre +0,5 D et +15 D. Si votre correction optique se situe dans ces plages, l'IPCLS peut améliorer votre vision de loin sans lunettes ni lentilles de contact.

L'implantation de l'IPCLS nécessite une intervention chirurgicale, qui comporte des risques potentiels. Veuillez lire attentivement cette notice et discuter avec votre médecin des risques éventuels.

Quelques-uns de ces risques sont décrits ci-dessous.

- Intervention chirurgicale supplémentaire
- Dans certains cas, une seconde intervention peut être nécessaire pour retirer, remplacer ou ajuster l'IPCLS. Elle peut également devoir être retirée lors d'une chirurgie de la cataracte. Une intervention supplémentaire peut aussi être nécessaire afin de réduire la pression intraoculaire.

Formation d'une cataracte
Après une chirurgie de la cataracte, il existe un risque accru que la lentille cristalline naturelle de votre œil devienne opaque et accorde, ce qui peut entraîner une cataracte nécessitant une intervention chirurgicale. Plus l'IPCLS reste longtemps dans l'œil, plus ce risque augmente. Les patients plus âgés et ceux qui présentent une myopie ou une hypermétropie plus importante peuvent présenter un risque plus élevé. Le risque à long terme au-delà de 7 ans n'est pas connu. Une chirurgie de la cataracte devient nécessaire, l'IPCLS ainsi que le cristallin opacifié sont retirés et une nouvelle lentille est implantée, comme lors d'une chirurgie standard de la cataracte.

Perte de la meilleure acuité visuelle corrigée (BCVA)

La cause la plus fréquente d'une diminution de la vision après l'IPCLS est la formation d'une cataracte.

Augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil (pression intraoculaire ou PIO) peut varier, mais elle est généralement comprise entre 10 et 21 millimètres de mercure (mmHg). Une pression intraoculaire supérieure à la normale est appelée hypertension oculaire et, si elle n'est pas traitée, peut provoquer une atteinte du nerf optique (glaucoma) et entraîner une perte permanente de la vision.

Perte de cellules endothéliales

La corne (la partie transparente située à l'avant de l'œil) possède une fine couche de cellules spécialisées appelées cellules endothéliales. Ces cellules maintiennent la transparence de la corne en éliminant l'excès de liquide. Normalement, le nombre de ces cellules diminue lentement avec l'âge. Une chirurgie oculaire, y compris l'implantation de l'IPCLS, peut entraîner une perte supplémentaire de ces cellules. Si un trop grand nombre de cellules est perdu, la corne peut devenir trouble et affecter votre vision. Avant l'intervention, votre médecin examinera vos yeux de près pour déterminer si vous êtes un candidat approprié pour l'IPCLS. Après l'intervention, une perte progressive de ces cellules peut continuer à se produire au fil du temps. Si un nombre trop important de cellules est perdu, du liquide peut s'accumuler dans la corne (dénommée œdème cornéen), ce qui peut nécessiter une transplantation de la corne.

Autres complications

- Les autres risques associés à la chirurgie IPCLS peuvent inclure :
 - déplacement de la zone colorée de l'œil (iris) à travers une plaie chirurgicale vers une position située à l'extérieur de l'œil (prolapsus de l'iris),
 - saignement dans la partie de la rétine responsable de la vision de lecture (hémorragie maculaire),
 - saignement sous la rétine (hémorragie sous-rétinienne),
 - augmentation du défaut de réfraction (astigmatisme),
 - décollement ou détachement de la rétine de sa position naturelle (détachement de la rétine),
 - différence de taille entre les pupilles (anisocorie).

Les effets indésirables et complications liés à la chirurgie ou survenant après celle-ci, ainsi qu'à l'implantation d'une lentille de contact phakique implantable, peuvent inclure, mais ne s'y limitent :

- Augmentation de l'astigmatisme
- Erreur réfractif
- Infection intraoculaire
- Problème de guérison
- Vauitisme
- Problème de guérison
- Augmentation de l'astigmatisme
- Erreur de réfraction
- Infection intraoculaire
- Perte de vision
- Problème de vision (vaunting)
- Cataracte sous-capsulaire antérieure
- Inflammation intraoculaire sévère
- Glaucoma
- Glaucoma secondaire
- Uvéite
- Hyphéma
- Under/over correction
- Non-reactive pupil
- Endophthalmitis
- TASS
- Retinal Detachment
- Iritis
- Cystoid macular edema
- Nuclear edema
- Corneal decompensation
- Corneal edema
- Papillary block
- Inc Capture
- IOP >5mmHg over baseline and IOP >25 mmHg
- Significant glare and/or halos around lights
- Decentration/rotation of the IPCLS
- Calcification of the retina
- Lens dislocation/rotation of the IPCLS
- Loss of best spectacle corrected visual acuity
- Secondary surgical intervention to remove/replace the IPCLS

PATIENTENINFORMATIONSBLETT

Produkttyp: Intraokularlinse (phak)

Einführung
Dieses Patienteninformationsblatt soll Ihnen dabei helfen zu entscheiden, ob bei Ihnen eine implantierbare phake Kontaktlinse (IPCLS) in einem oder beiden Augen eingesetzt werden soll, um Ihre Kurzsichtigkeit (Myopie) oder Weitsichtigkeit (Hyperopie) zu korrigieren. Es ist wichtig, die Vorteile und möglichen Risiken zu verstehen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt sorgfältig durch und besprechen Sie alle Fragen mit einem Arzt, der in der IPCLS-Chirurgie geschult ist.

Was sind Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit?

NORMALES AUGE
Das Licht wird auf der Netzhaut fokussiert. Das Sehvermögen ist klar.

NORMALES AUGE:
Ihr Auge funktioniert wie eine Kamera. Sie sehen Objekte, weil Ihr Auge das Licht zu Bildern fokussiert. Sowohl die transparente vordere Schicht Ihres Auges, die Hornhaut, als auch Ihre natürliche Auglinse bündeln die Lichtstrahlen auf der Rückseite des Auges, die sogenannte Netzhaut.

KURZSICHTIGES AUGE:
Kurzsichtigkeit ist ein Brechungsfehler, der dazu führt, dass das Sehen in der Ferne unscharfer ist als das Sehen in der Nähe. Das Licht, das von einem weit entfernten Objekt kommt, wird vor der Rückseite Ihres Auges (der Netzhaut), die für die Bildaufnahme verantwortlich ist, fokussiert, anstatt direkt auf der Netzhaut.

KURZSICHTIGES AUGE:
Das Licht wird vor der Netzhaut fokussiert. Das Sehvermögen ist unscharf.

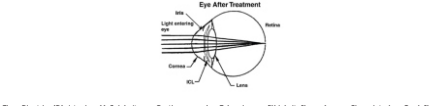
WEITSICHTIGES AUGE
Das Licht wird hinter der Netzhaut fokussiert. Das Sehvermögen ist unscharf.

WEITSICHTIGES AUGE:
Weitsichtigkeit (Hyperopie) ist eine häufige Sehschwäche, bei der entfernte Objekte klar gesehen werden können, während nahe Objekte unscharf erscheinen können.

Brillen und Kontaktlinsen können Ihren Augen helfen, das Licht korrekt auf die Netzhaut zu fokussieren. Auch die IPCLS kann Ihnen Augen helfen, das Licht korrekt auf die Netzhaut zu fokussieren.

Wie korrigiert die IPCLS Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit?

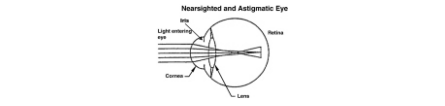
SEHKORREKTUR NACH EINER IPCLS-OPERATION



Eine Dioptrie (D) ist eine Maßeinheit zur Bestimmung der Fokussierungsfähigkeit Ihres Auges. Sie zeigt den Grad Ihrer Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Ihres Astigmatismus. Die IPCLS-Operation kann Kurzsichtigkeit von -0,5 D bis -15,0 D und Weitsichtigkeit von +0,5 D bis +15,0 D behandeln. Wenn Ihre Weitsichtigkeit innerhalb dieser Bereiche liegt, kann Ihnen diese Operation helfen, ohne Brillen oder Kontaktlinsen klar zu sehen.

Die IPCLS wird ein künstliches Hornhautlinsen-System (IPCLS) mit einem häufigen Sehschwäche, bei der entfernte Objekte klar gesehen werden können, während nahe Objekte unscharf erscheinen können.

KURZSICHTIGES UND ASTIGMATISCHES AUGE



Die IPCLS Toric / IPCLS Presbytic Toric kann Astigmatismus von +1,0 D bis +10,0 D korrigieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, um die für Ihr Auge am besten geeignete Option auswählen.

Die beste Linse für Ihr Sehvermögen auswählen
Es stehen verschiedene Linsentypen zur Verfügung. Ihr Augenarzt wird Ihnen helfen, die für Sie am besten geeignete Linse auszuwählen. Weitere Behandlungsoptionen umfassen Brillen, Kontaktlinsen oder Kontaktlinsen. Besprechen Sie alle Fragen mit Ihrem Augenarzt über die Vorteile und möglichen Risiken jeder Option.

Andere Behandlungsmöglichkeiten zur Korrektur von Kurz- und Weitsichtigkeit?
Zu den anderen Behandlungsmöglichkeiten zur Korrektur von Kurz- und Weitsichtigkeit gehören Brillen, Kontaktlinsen und refraktive chirurgische Verfahren. Zu den chirurgischen Optionen zählen die photorefraktive Keratektomie (PRK), die laserassistierte In-situ Keratomilexis (LASIK), der refraktive Linsenaustausch (RLE) sowie die Implantation einer phakischen Intraokularlinse (z. B. IPCLS). Allerdings können diese Verfahren möglicherweise nicht den Sehansprüchen bestimmter Berufe, beispielsweise im Militär, entsprechen.

Diese Verfahren verändern entweder die Form der Hornhaut oder platzieren eine Linse im Inneren des Auges. PRK und LASIK verwenden einen Laser, um die Form der Hornhaut zu verändern und dadurch die Fokussierungsfähigkeit des Auges zu verbessern. Bei LASIK wird ein kleiner Teil der Hornhaut abgetragen, um das darunterliegende Gewebe mit dem Laser zu bearbeiten, und die Hornhautflächen anschließend wieder zurückgelegt, damit sie verheilen kann. Die Implantation einer phakischen Intraokularlinse, wie der IPCLS, fügt dem Auge eine künstliche Linse hinzu, ohne die natürliche Linse zu entfernen.

Vorteile und Risiken der IPCLS

Die normale Augeninnendruck (intraokulärer Druck oder IOP) kann variieren, liegt normalerweise zwischen 10 und 21 Millimeter Quecksilber (mmHg). Ein höherer als normaler Augeninnendruck wird als okulare Hypertonie bezeichnet und kann verbunden zu einer Schädigung des Sehnervs (Glaucoma) und zu dauerhaften Sehverlust führen.

Ein erhöhter Augeninnendruck und Schädigung des Sehnervs durch erhöhten Augeninnendruck (Glaucoma)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)
Die häufigste Ursache war die Erhöhung der netzhautigen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen durch Kataraktbildung verbessern.

Foglio Informativo per il Paziente

Tipi di Dispositivo: Lente Intraoculare (Facia)

Introduzione
Questo foglio informativo per il paziente è stato progettato per aiutarvi a decidere se desiderate l'implanto di una Lente a Contatto Facciale Implantabile (IPCLS) in uno o entrambi gli occhi per correggere la miopia o l'ipermetropia. È importante comprendere i benefici e i possibili rischi prima di prendere una decisione. La invitiamo a leggere attentamente questo foglio informativo e a discutere le domande con un medico specializzato nella chirurgia IPCLS.

Che cosa sono la miopia e l'ipermetropia?

OCCHIO NORMALE
La luce si focalizza sulla retina. La visione è nitida.

OCCHIO NORMALE:
Il vostro occhio funziona come una macchina fotografica. Vedete gli oggetti perché l'occhio mette a fuoco la luce proveniente da un oggetto lontano, denominata cornea, sia il cristallino naturale focalizzano i raggi luminosi sulla superficie posteriore dell'occhio, chiamata retina.

OCCHIO MIOPICO
La luce si focalizza davanti alla retina. La visione è sfocata.

OCCHIO MIOPICO:
La miopia è un errore di messa a fuoco che provoca una visione più sfocata da lontano rispetto a quella da vicino. La luce proveniente da un oggetto distante è focalizzata davanti alla superficie posteriore dell'occhio (retina), responsabile della formazione delle immagini, anziché direttamente sulla retina.

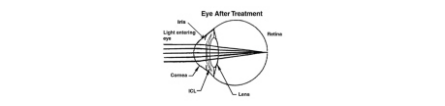
OCCHIO IPERMETROPE
La luce si focalizza dietro la retina. La visione è sfocata.

OCCHIO IPERMETROPE:
L'ipermetropia è un comune difetto visivo in cui è possibile vedere chiaramente gli oggetti lontani, mentre quelli vicini possono apparire sfocati.

Gli occhiali e le lenti a contatto possono aiutarvi l'occhio a focalizzare correttamente la luce sulla retina. Anche la IPCLS può aiutare l'occhio a focalizzare correttamente la luce sulla retina.

Come corregge la IPCLS la miopia e l'ipermetropia?

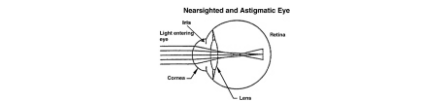
CORREZIONE DELLA VISIONE DOPO L'INTERVENTO CON IPCLS



La diottria (D) è un'unità di misura utilizzata per valutare la capacità dell'occhio di mettere a fuoco. Indica il grado di miopia, ipermetropia o astigmatismo che avete. La IPCLS può trattare la miopia da -0,5 D a -15,0 D e l'ipermetropia da +0,5 D a +15,0 D. Se la vostra visione rientra in questi intervalli, questo intervento può aiutarvi a vedere chiaramente senza occhiali o lenti a contatto.

La lente monofocale IPCLS non corregge l'astigmatismo. L'astigmatismo è un problema visuale comune che provoca una visione sfocata o irregolare. Si verifica quando la superficie anteriore dell'occhio (cornea) non ha una forma uniforme. Per questo motivo, la luce non viene focalizzata correttamente all'interno dell'occhio e alcune parti di ciò che vedete possono apparire più nitide di altre.

OCCHIO MIOPICO E ASTIGMATICO



La IPCLS Toric / IPCLS Presbytic Toric può correggere l'astigmatismo da +1,0 D fino a +10,0 D. Vi invitiamo a consultare il vostro medico per scegliere l'opzione più appropriata e adatta al vostro occhio.

Scelta della lente migliore per la vostra vista
Sono disponibili diversi tipi di lenti. Il vostro oculista vi aiuterà a scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Altre opzioni di trattamento includono occhiali con lenti

